Anémie et grossesse : une cause majeure de mortalité et morbidité maternelle négligée ?

Pr Zamané Hyacinthe, Gynécologue Obstétricien

Unité de formation et de recherche en sciences de la santé, Université Joseph KI-ZERBO

Plan

- Introduction
  1. Généralités
  2. Causes
  3. Démarche diagnostique
  4. Conséquences
  5. Prise en charge
- Conclusion

Introduction

- Mortalité maternelle = problème de santé publique
- Ratio de mortalité maternelle au Burkina Faso: 198 / 100 000 NV
- Hémorragie = première cause obstétricale directe
- Anémie = première cause obstétricale indirecte
- Responsable de décès évitable

Introduction

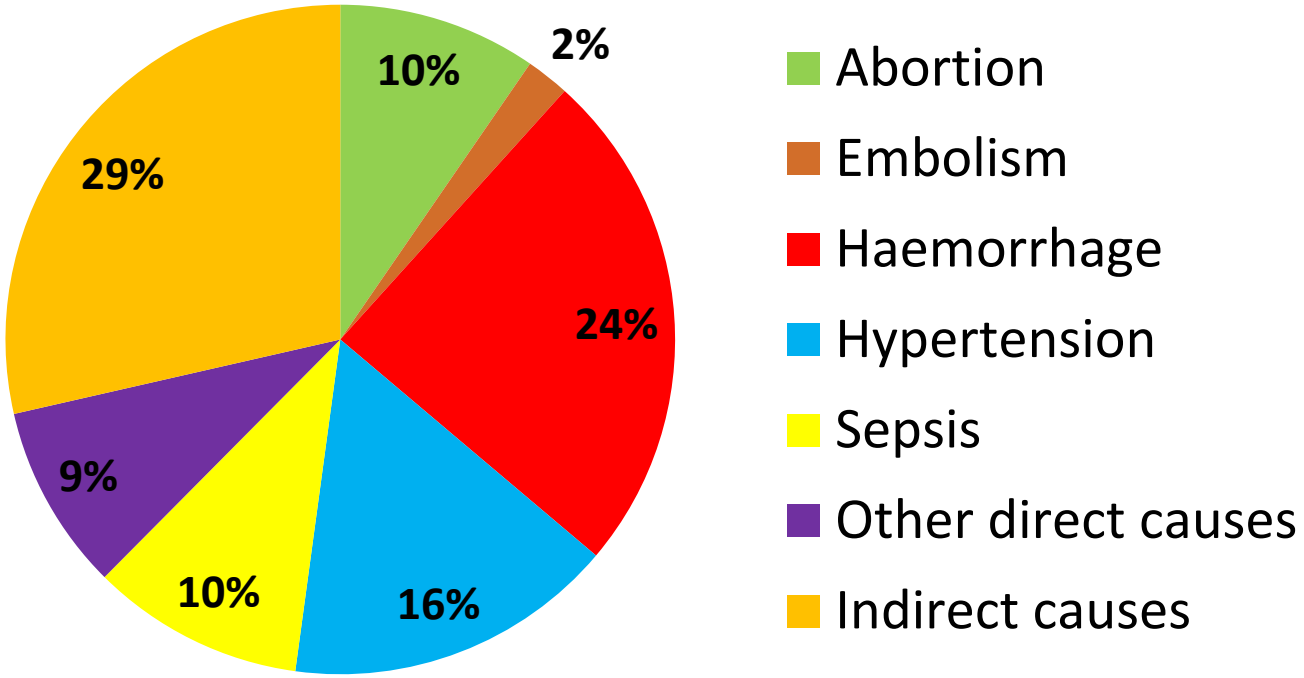
- Association fréquente
- Conditionne le pronostic maternel et celui du produit de conception
- Problème de santé publique

Introduction

- La cible 3 des objectifs de développement durable (ODD) vise une réduction du nombre de décès maternels dans le monde à moins de 70 pour 100.000 naissances vivantes d'ici à 2030
- Aucun pays ne devrait avoir un taux de mortalité maternelle supérieur à 02 fois la moyenne mondiale : 140 pour 10 0000 NV.

Introduction

Causes des décès maternels en ASS (2017, UN)

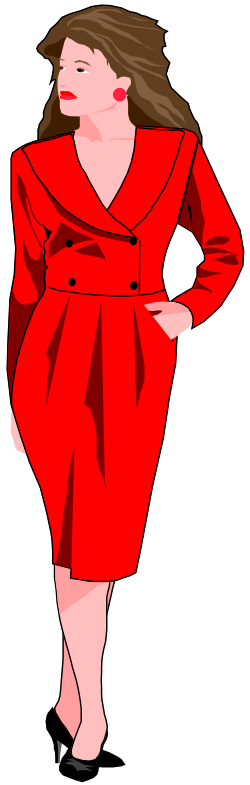


Causes indirectes: **anémie**, paludisme, VIH etc.

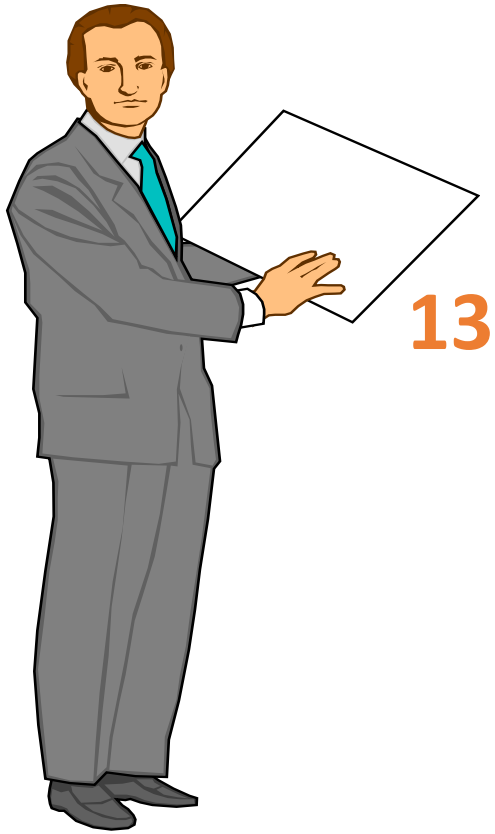
OMS, UNICEF, UNFPA, Groupe Banque Mondiale. Evolution de la mortalité maternelle 2000-2017

1. Généralités

1. Généralités



12-14 g/dl



13-15 g/dl

1. Généralités

1.1 Définition de l'anémie chez la femme enceinte

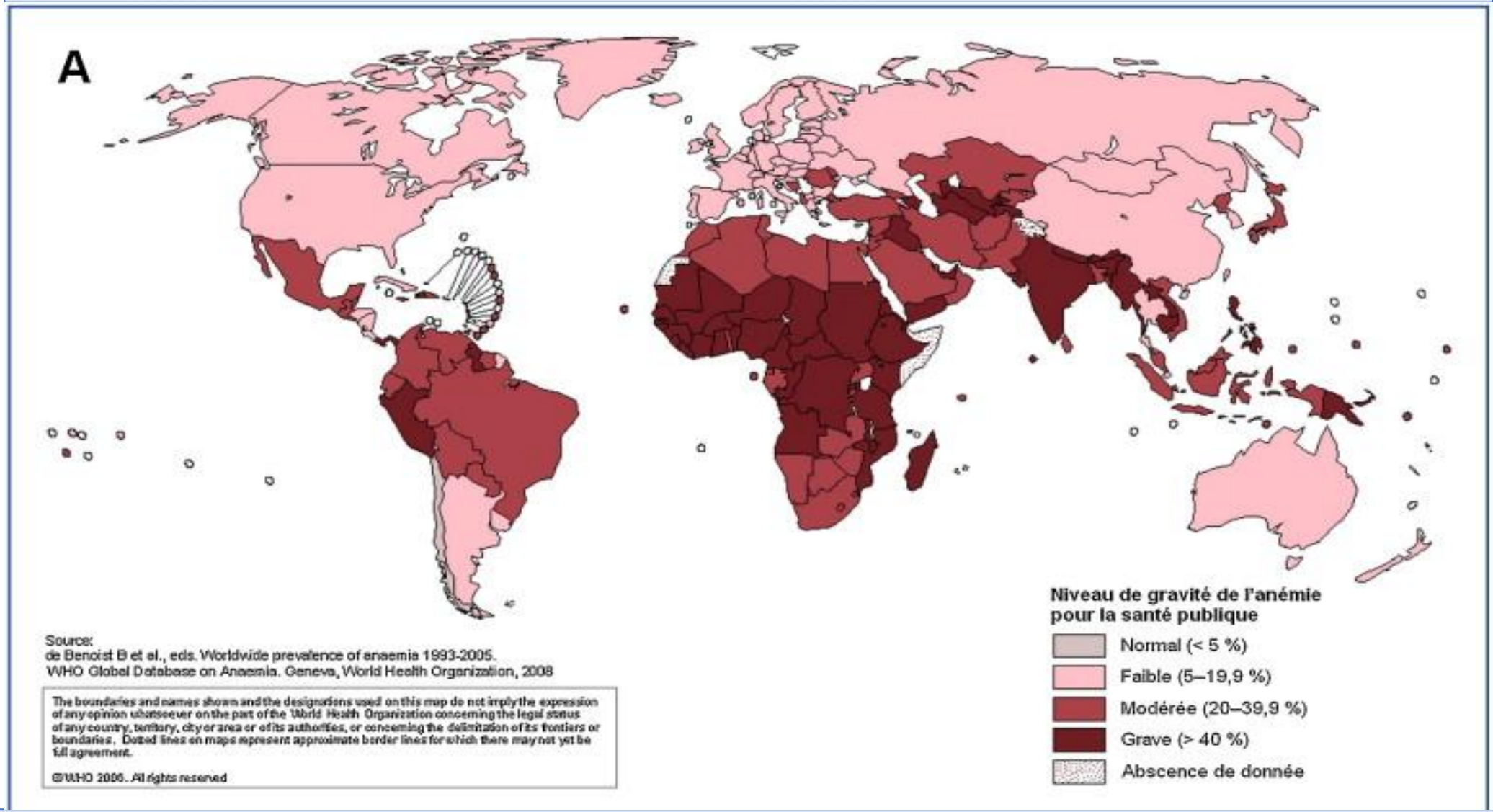
- L'anémie chez la femme enceinte se définit comme étant la baisse de la concentration de l'Hb en dessous de 11g/dl (OMS).
- Gravité?
  - Anémie légère : 10-10,9 g/dl
  - Anémie modérée : 7- 9,9 g/dl
  - Anémie sévère : < 7g/dl

1. Généralités

1.2. Intérêts

- Épidémiologique: > 50% des gestantes dans les pays en développement
- Diagnostique : recherche étiologique +++
- Thérapeutique: prévention +++
- Pronostique

1. Généralités



1. Généralités

1.3. Rappels physiologiques:

Grossesse → hémodilution

↓

Diminution hyperviscosité sanguine

↓

Fluidité sanguine → bonne perfusion placentaire et échange optimal d'oxygène

1. Généralités

- Besoins en fer ↗
- Réponse fonction de l'état des réserves antérieures à la grossesse
- Alimentation normale équilibrée ➔ apport moyen de 20 mg de fer journalier dont seulement 10 à 15 % sont absorbés
- Sans carence: déroulement normal de la grossesse.

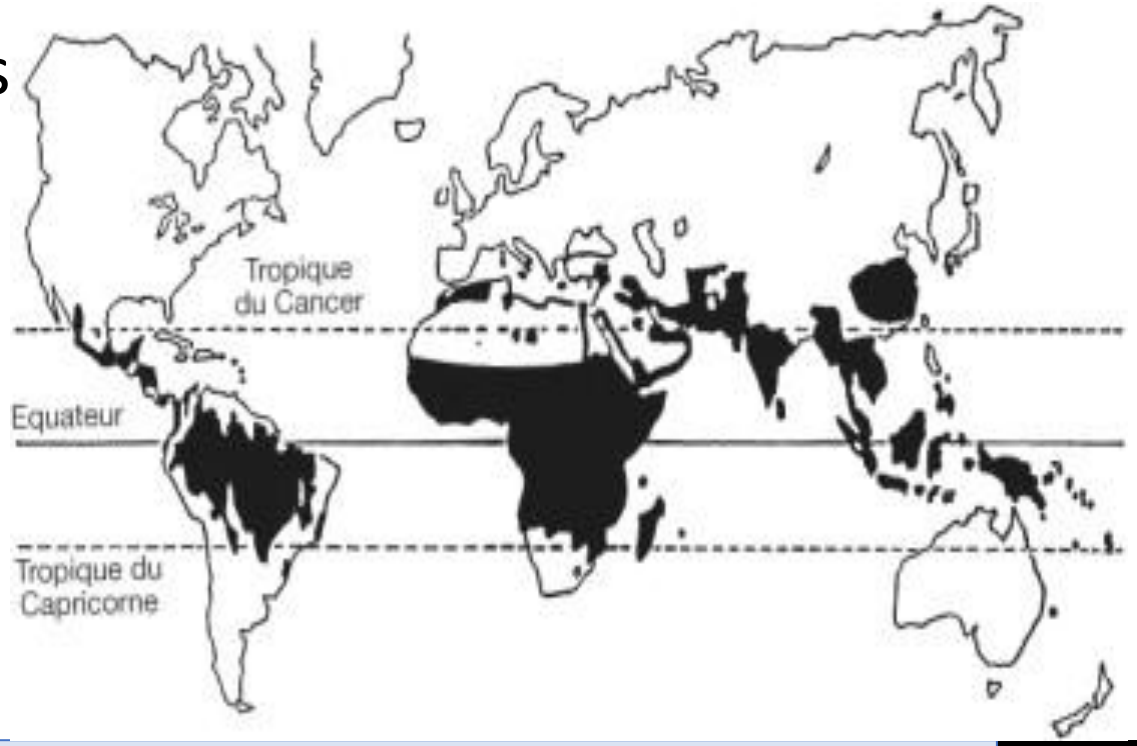
2. Causes

2. Causes

- **Anémies carencielles** :
  - Insuffisance d'apport / malabsorption
  - Fer, acide folique, vitamine D, carences protidiques
- **Anémies par spoliation sanguine** :
  - 1er trimestre (avortement, GEU)
  - 2ème et 3ème trimestre (PP, HRP, RU)
  - HPD et du postpartum)

2. Causes

- Anémies d'origine infectieuse :
  - Parasitaires : paludisme+++ parasitose intestinale
  - Bactérienne : pyélonéphrite, sepsis
  - Virales : infection à VIH



2. Causes

- Hémoglobinopathie : drépanocytose +++
- Autres types d'anémies :
  - Maladies inflammatoires chroniques,
  - Enzymopathie,
  - Cirrhose,
  - Anémie de BIERMER
- Anémies de causes multifactorielles

2. Causes

- Facteurs favorisants
  - Bas niveau socio économique
  - Multiparité
  - Grossesses trop rapprochées
  - Grossesses trop précoces
  - Grossesses trop nombreuses
  - Grossesses multiples

3. Diagnostic

3. Diagnostic

3.1. Signes cliniques:

Signes fonctionnels : polymorphes

- Asthénie, épuisement physique, émotionnel ou psychologique
- Vertiges
- Dyspnée, palpitations au repos, lipothymie
- Intolérance à l'effort
- Céphalées, acouphènes
- Irritabilité, insomnie
- Difficultés de concentration, étourdissements
- Anorexie

3. Diagnostic

3.1. Signes cliniques:

Signes généraux

- Pâleur des téguments
- Décoloration des conjonctives et des ongles
- Subictère / ictère selon le mécanisme de l'anémie
- OMI
- Accélération du pouls
- Baisse de la TA, voir un état de choc
- Fréquence cardiaque; pouls
- Fréquence respiratoire?

3. Diagnostic

3.1. Signes cliniques:

Signes physiques: non spécifiques

- Retentissement obstétrical:
- Petite HU
- ↘ des MAF
- Anomalies du rythme cardiaque fœtal
- Modifications cervicales

3. Diagnostic

3.1. Signes cliniques:

Autres signes physiques:

- Souffle systolique à l'auscultation cardiaque
- Hépatomégalie
- Splénomégalie

3. Diagnostic

3.1. Signes cliniques:

3.2. Signes para cliniques:

- **Hémogramme :**
  - Concentration en hémoglobine
  - VGM: Microcytose (anémies ferriprives) / Macrocytose (carence en acide folique)
  - CCMH : Hypochrome / Normo hypochrome
  - Réticulocyte
  - Autres lignée ? Globules blancs / Plaquettes

3. Diagnostic

3.2. Signes para cliniques:

- **Bilan martial**
  - Ferritine
  - Coefficient de saturation en transferrine
  - CRP / VS
- **Acide folique (Vit B9)**
- **Electrophorèse de l'Hémoglobine**
- **Examen de la moelle : le myélogramme**

3. Diagnostic

3.2. Signes para cliniques:

- Recherche de foyers infectieux: ECBU
- GE / frottis sanguin
- Examen de selles KOP

Diagnostic d 'une anémie
3 étapes

1- Est-ce bien une anémie ?

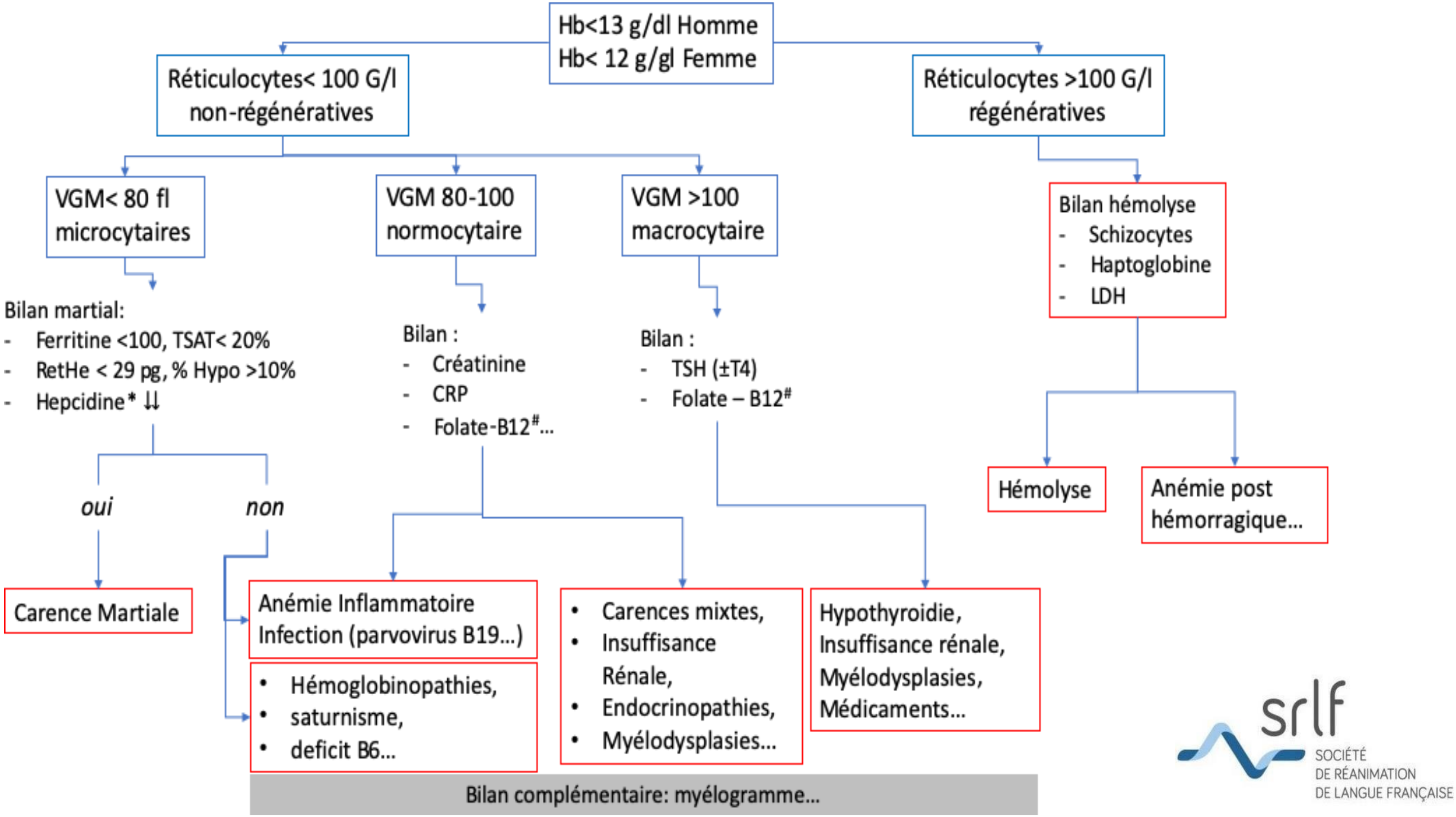
Hb < 11 g/dl

2-Quel est son mécanisme ?

3-Quelle est sa cause ?

Examens complémentaires argumentés

Question 1: arégénérative ?	Production affectée
Question 2: régénérative ?	Hémolyse? Hémorragie?


Hb<13 g/dl Homme
Hb< 12 g/gl Femme
Réticulocytes< 100 G/l non-régénératives
Réticulocytes >100 G/l régénératives
VGM< 80 fl microcytaires
VGM 80-100 normocytaire
VGM >100 macrocytaire
Bilan hémolyse
- Schizocytes
- Haptoglobine
- LDH
Bilan martial:
- Ferritine <100, TSAT< 20%
- RetHe < 29 pg, % Hypo >10%
- Hepcidine* ⇊
Bilan :
- Créatinine
- CRP
- Folate-B12#...
Bilan :
- TSH (±T4)
- Folate – B12#
oui
non
Hémolyse
Anémie post hémorragique...
Carence Martiale
Anémie Inflammatoire
Infection (parvovirus B19...)
• Hémoglobinopathies,
• saturnisme,
• deficit B6...
• Carences mixtes,
• Insuffisance Rénale,
• Endocrinopathies,
• Myélodysplasies...
Hypothyroidie,
Insuffisance rénale,
Myélodysplasies,
Médicaments...
Bilan complémentaire: myélogramme...
srlf
SOCIÉTÉ DE RÉANIMATION DE LANGUE FRANÇAISE

4. Conséquences

4. Conséquences

4.1. Sur la mère

- Augmentation de la morbidité et de la mortalité maternelle
- Faiblesse et baisse de la productivité chez la mère
- Décompensation cardiaques
- Infections
- Dystocies dynamiques
- HPP
- Accidents thromboemboliques
- Décès

4. Conséquences

4.2. Sur le produit de conception

- Avortements
- Prématurité
- Retards de croissance intra utérin
- Souffrance fœtale
- Mort fœtale in utero
- Décès néonatal

4. Conséquences

4.3. Eléments de mauvais pronostic

- Mode d'installation: caractère aigu
- Sévérité
- Tare associée
- Existence de décompensation
- Retard de prise en charge

5. Prise en charge

5. Prise en charge

5.1. Préventive

- Espacement idéal des grossesses
- Dépistage précoce de l’anémie (SPN)
- Déconseiller les pratiques nuisibles telles que la géophagie
- Information / sensibilisation sur l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un suivi prénatal régulier est crucial
- Education nutritionnelle

5. Prise en charge

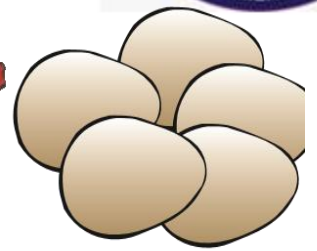
1-Aliment à base de céréales racines et tubercules

2-Haricot et pois

3-Noix et graines

4-Produits laitiers

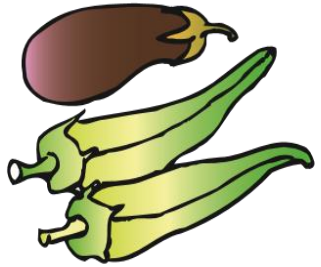
5-Aliments carnés (viande, poisson, volaille, foie/abats)



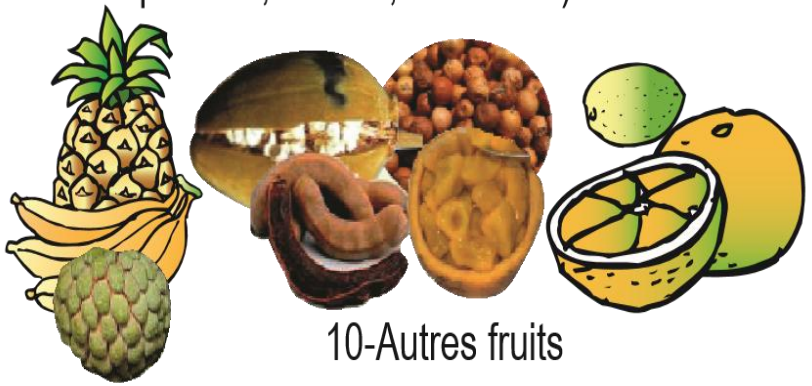
6-Oeuf

7-Feuilles verts-foncées riches en vit A

8-Autres fruits et légumes riches en vit A



9-Autres légumes



10-Autres fruits

Consommer au moins cinq des dix groupes d'aliments par jour

5. Prise en charge

Un repas supplémentaire est nécessaire pour répondre aux besoins du fœtus en pleine croissance

5. Prise en charge

5.1. Préventive

- Supplémentation en fer : **S'ASSURER DES PRISES**
- Supplémentation en acide folique
- Prévention du paludisme
- Déparasitage systématique

5. Prise en charge

5.2. Curative

- Transfusion : < 7g/dl ou signes d'intolérance
- Fer à dose curative de 120 à 140mg de fer/jr
- Acide folique à la dose de 10 à 20mg /jr
- Oxygénothérapie si anémie décompensée
- Traitement étiologique de l'anémie : « ***Le traitement doit cibler la maladie sous-jacente*** ».

5. Prise en charge

5.2. Curative

A l'accouchement

- Réduction de la durée du travail d'accouchement
- Éviter les poussées excessives
- GATPA

5. Prise en charge

5.2. Curative

Postpartum

- Prévention des accidents thromboemboliques : moyens mécaniques
- Régime hyper protidique
- Poursuivre le fer jusqu'au 3ème mois

5. Prise en charge

5.2. Curative

Approche pluridisciplinaire selon l'étiologie : Hématologue +++

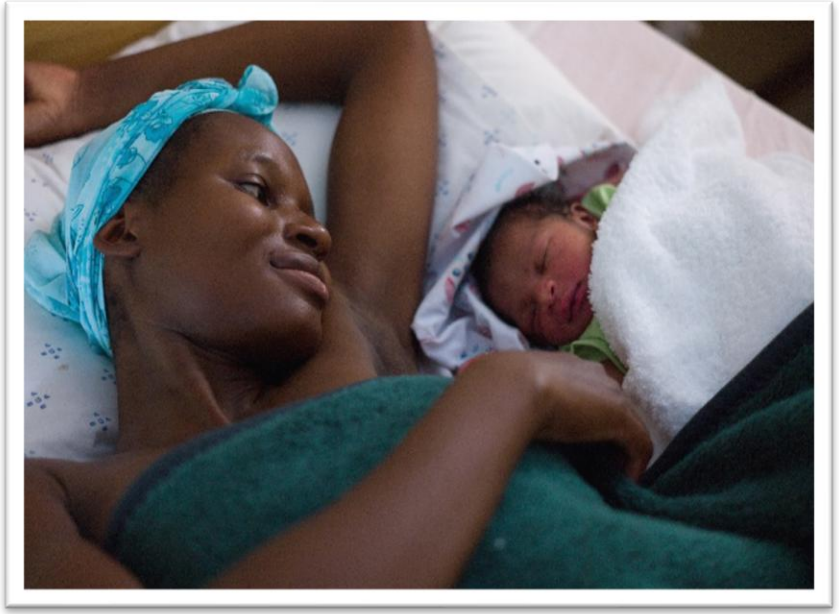
Particularités chez la femme drépanocytose

- Acide folique 5 mg : 2 comprimés par jour
- Fer **SELON** le bilan martial
- Transfusion si Hb < 8 g/dl (taux doit resté inférieur à 12 g/dl sinon hyperviscosité)
- Échange transfusionnel selon les cas: objectif Hb S < 40 % et Hb A > 30 %

Conclusion

- Anémie fréquente chez la femme enceinte
- Origine multifactorielle
- Importance de la prévention
- Prise en compte de l'étiologie

Veillons à ce que chaque femme, en donnant la vie reste en vie et en bonne santé avec son nouveau-né



Merci pour votre attention